居家血糖管理与 AI 复诊辅助产品

目录

1 执行摘要 3

2 研究背景与目标 4

3 行业与市场概况 4

3.1 需求规模与家庭中的管理任务 4

3.2 产品供给与发展变化 5

3.3 AI 已出现在哪些环节 5

3.4 用户支持与使用门槛 5

4 竞品选择及分析方法 6

4.1 候选筛选与当前状态 6

4.2 产品身份与比较单元 6

4.3 证据分层与体验覆盖 7

4.4 评论采样与取舍 7

4.5 原始资料保存 7

5 竞品逐一分析 8

5.1 糖护士 8

5.2 爱看健康与小诺智能体 9

5.3 瞬感宝及瞬感云和瞬感通生态 10

5.4 平安好医生 11

6 竞品功能对比矩阵 12

6.1 采集与日常管理 12

6.2 AI 与医疗协作 13

7 核心业务流程与用户体验分析 14
7.1 公开入口实际走查 14
7.2 记录与趋势的信息结构 15
7.3 摘要理解与服务入口 16
7.4 从记录到共享的流程分析 17
8 用户痛点与需求分析 18
8.1 有来源支持的用户问题 18
8.2 从已有证据到待验证需求 19
8.3 用户分群与优先顺序 19
9 市场机会及产品差异化分析 20
9.1 已经成熟的能力与剩余空间 20
9.2 AI 可能创造价值的具体环节 20
9.3 数据与服务边界对定位的影响 20
10 候选产品定位比较 21
11 推荐的产品方向及后续建议 22
11.1 推荐优先验证方向 A 22
11.2 产品交付模式与首版范围 22
11.3 进入需求分析前的验证安排 23
11.4 决策标准 23
12 参考资料与证据索引 24
12.1 选用评论索引 27
12.2 证据覆盖与研究复核 28

1 执行摘要

国内居家血糖管理已形成三类主要供给：围绕记录与多设备数据管理的专门 App，围绕传感器运行的 CGM 配套软件，以及围绕医生服务和支付权益的互联网医疗平台。本次选取四款有近期维护或持续服务证据的代表产品，覆盖这三类路径。公开资料缺少可横向比较的国内活跃患者数据，因此采用代表性样本，不做使用人数排名。

基础血糖记录、历史查询、曲线和统计已相当成熟。糖护士公开支持多个 CGM 品牌的数据对接；爱看健康把动态监测、生活记录、AI 解读与专业团队结合；瞬感体系具备标准化报告和医生、家属共享路径；平安好医生的优势集中在家庭医生、问诊及后续医疗服务。[8—25]

AI 竞争已进入具体应用环节。小诺智能体公开提供饮食相关分析和健康洞察，糖护士披露 IDSS 及大模型相关能力，平安好医生提供药品识别与医典自查。产品宣传中“智能分析”、规则反馈、生成式助手和人工服务需要分别辨认，功能效果与实际开放范围也需要分别验证。[11、15、23、25]

关键判断	对立项的影响
记录和报告已有充分供给	单独增加曲线、问答或通用报告，很难构成持续使用理由。
数据连续性仍有实际摩擦	评论出现重复同步、查找历史细节和连接稳定性问题；优先研究数据质量与使用连续性。
复诊背景整理有待验证	既有报告主要展示指标与趋势。用药变化、症状、记录缺口、患者问题如何一起进入问诊，是值得深入观察的环节。
低门槛使用依赖服务支持	老年患者质性研究显示学习和支持障碍；降低输入负担需要与家属、医生及既有工具协同。

推荐优先研究“已有监测记录的 2 型糖尿病患者，在门诊复诊前整理资料和问题”的场景。其竞争差异可以来自可追溯的跨来源整理、患者确认和适合门诊阅读的信息结构。当前证据支持这一方向值得验证，尚缺直接观察医生阅读效果、患者使用频率和付费主体的资料。

另外两个候选方向是日常饮食与血糖解释助手、面向家属的低门槛协同管理。前者与现有 AI 产品高度重叠，后者有明确的支持需求，但需要解决双方设置、权限和长期照护责任的复杂性。

2 研究背景与目标

本项目处于产品立项前阶段，研究对象是市场上已经出现的需求和解决方式。研究结果用于决定服务谁、在哪个环节创造价值，以及哪些问题需要进一步访谈和验证。既有项目实现、演示数据和假定功能均未作为本报告依据。

研究沿着一次居家管理到复诊的过程展开：产生记录，保存并查看历史，理解变化，采取日常行动，准备资料，与医生交流。对竞品的评价围绕这些任务的完成条件展开，关注输入成本、数据连续性、解释质量、共享方式和服务接续。

研究问题与判定口径

问题	本次采用的证据
产品是否仍维护和提供服务	当前中国区上架元数据、近期更新、官方入口及企业披露交叉核对。
功能是否存在且可用	分别记录官方说明、展示界面和实际走查结果；涉及账号或设备的功能列出前置条件。
用户为什么会遇到困难	定性研究、具体评论和可见交互结构相互印证；新增推断标为需求假设。
新产品应进入哪个环节	先比较成熟能力，再判断剩余任务、竞争强度、实施依赖和验证成本。

3 行业与市场概况

3.1 需求规模与家庭中的管理任务

IDF 资料显示，2024 年中国 20—79 岁糖尿病患者约 1.48 亿。可触达的数字健康用户还取决于诊断、监测习惯、手机使用、设备支付能力和医疗服务连接方式。[1]

居家管理不只包含记录一个数值。国内行为和生活方式干预指南将饮食、活动、体重、用药、监测、心理应对及社会支持放在同一管理框架中。对产品而言，价值来自帮助患者形成可持续行动，并在需要时获得专业帮助。[3]

CGM 指连续葡萄糖监测；TIR 是目标范围内时间比例；AGP 是动态葡萄糖图谱。指尖监测与 CGM 的采集频度、测量方式和解释条件不同，比较时需保留来源与数据覆盖范围。[18、22]

3.2 产品供给与发展变化

2023 年发表的一项中国市场评估纳入 66 款糖尿病管理 App，检索截至 2022 年 12 月。研究发现功能完整性仍有差异，多数产品难以覆盖全部管理任务。该研究提供了早期产品供给的背景；本次对当前产品的判断采用 2026 年公开资料。[4]

当前样本体现了两项变化。第一，采集从手动记录扩展为设备自动同步和多源聚合，竞争焦点逐步转向数据是否完整、连接是否可靠、能否解释。第二，服务从单纯展示指标延伸到算法反馈、专业团队及家庭医生，数据与实际服务的连接更紧密。[8、14、18、23]

3.3 AI 已出现在哪些环节

实际公开应用	证据与当前范围	产品意义
记录与饮食理解	爱看版本记录披露食物拍照、饮食卡片和餐后分析。[15]	减少描述成本，但份量和场景仍需要确认。
趋势与模式解释	糖护士 IDSS；小诺健康洞察及多日规律分析。[8、15]	将数据转为解释，需保留时间范围和输入依据。
健康服务入口	平安好医生药品识别、医典自查，以及公司 AI 与医生协同策略。[23、25]	降低找服务的成本，价值依赖后续服务承接。
提前预警	爱看 2.6.0 高低血糖预测预警以体验官计划公布。[15]	仍属限定开放信息，不能按全量通用功能比较。

上述应用的成熟度并不一致。版本说明可以确认功能被发布或测试；判断分析是否可靠，需要了解使用人群、数据条件和验证结果。本次未获得可用于横向比较的独立 AI 效果评测，因而不按“谁更智能”排序。

3.4 用户支持与使用门槛

2026 年针对 19 名中国老年糖尿病患者的质性研究发现，操作复杂、时间成本、传统管理偏好和信心不足影响移动健康使用，家属及医护支持有促进作用。另一项北京社区研究涉及 32 名 2 型糖尿病患者，呈现知识不足、监测不规律及支持分散等问题。这些资料提示，信息供给之外还需要持续协助和适合个人习惯的流程。[5、6]

4 竞品选择及分析方法

4.1 候选筛选与当前状态

产品	截至研究日取得的状态证据	纳入决定
糖护士	中国区 iOS 4.3.34，更新于 2026-10-28；Android 商店有 2026 年更新；官网可读。	纳入。专门管理与跨设备聚合代表。
爱看健康 小诺智能体	iOS 2.6.0，更新于 2026-10-31；官网提供多系统下载。小米渠道显示维护中。	纳入。国产 CGM、AI 和服务一体化代表。
瞬感宝及配套生态	iOS 2.13.1，版本时间 2026-04-14 UTC；中国官网、商店及支持文档持续可获取。	纳入。CGM 报告与共享生态代表。
平安好医生	iOS 9.50.0，更新于 2026-11-02；公开移动网页和 2026 中期报告可查。	纳入。综合医疗服务间接竞品。
掌控糖尿病	中国区元数据仍返回 5.1.2，最后版本时间 2020-03-10；核心服务未验证。	保留历史参照，当前维护证据较弱。
微糖	历史 App ID 的中国区查询未返回；旧官网及详情读取失败，仅有历史介绍。	不纳入正式矩阵，当前患者端状态待核。

依据 [8、12—16、18、23—27]。版本日期采用 Apple 元数据 UTC 日期；北京时间显示可能相差一天。

正式样本均具有当前维护或服务供给证据，四款的核心手机功能则主要由官方资料确认。当前环境未完成安装、注册和真实设备验证，运营判断与功能实测结果分别记录。微糖、掌控的筛选结果只涉及所查患者端产品。

4.2 产品身份与比较单元

“平安健康”涉及企业品牌和不同应用。本报告采用开发者为平安健康互联网、App ID 为 1552354076 的平安好医生，避免与保险服务类同名应用混淆。瞬感则以患者端 App 为中心，同时考察其报告和共享配套工具；不把全球版支持文档中的全部能力直接计入中国版。[18、21—25]

样本选择优先考虑任务相关性和方案差异。产品之间的设备前置条件、医生资源和付款渠道不同，比较结果用于识别能力边界，不形成一个总分榜单。

4.3 证据分层与体验覆盖

标签	含义	本报告中的使用方式
体验	研究者在公开网页实际打开、点击或读取	用于入口和引导观察；保留现场截图与日志。
官方	官网、开发者说明、版本记录及支持手册	确认公开提供的功能、条件和流程；手机端未完成验证。
评论	公开用户自述，保留时间、版本、原 ID	定位具体摩擦；避免把历史反馈直接写成当前版本缺陷。
研究	论文、指南、可靠统计	支持需求与管理背景，标明样本和时间范围。
分析	研究者据上述资料作出的判断或建议	明确推理与待验证条件，不作为已观察事实。

实际体验完成了糖护士官网与下载跳转、爱看健康下载页、平安好医生公开首页的局部走查。访问雅培官网时可访问文本未正常呈现；糖护士的应用宝落地页被浏览器工具权限机制阻断。后续使用其他公开来源继续核对，未把该页面的阻断归为产品问题。

本次可控环境为 Windows，未具备测试手机、产品账号和 CGM 传感器。原生注册、保存血糖、历史回读、实时同步、个人报告导出及家属接收均未完成。第 7 章仅对可见界面分析信息结构，对官方文档整理参考流程，不报告手机端点击数或耗时。

4.4 评论采样与取舍

2026 年 11 月 2 日从 Apple 中国区按最近排序取得每款 50 条评论，共 200 条。围绕录入、同步、历史查询、理解、共享及咨询连续性筛选具体事件；保留原始 JSON 和评论版本。购物物流、空泛评分以及产品身份不明确的内容不用于糖尿病管理痛点归纳。[30—33]

爱看健康这 50 条均为 5 星，集中于 2026 年 10 月 29—31 日；其余产品的 50 条覆盖了更长时期。因此本报告使用评论呈现具体问题和正向体验，评价分数与差评比例不作横向比较。

4.5 原始资料保存

研究目录保存官网与商店页面、版本接口结果、四组原始评论、官网现场截图、商店展示图、平安中期报告及检索记录。来源清单与下载清单记录网址和取得状态；失败来源、操作边界及排版验证记录分别留存在研究日志与 QA 目录。

5 竞品逐一分析

5.1 糖护士

定位与用户。糖护士面向需要长期自我管理的糖尿病及痛风人群，将手动记录、连接设备和数据反馈放在一个应用中。对本项目最重要的参照价值，是它已经把指尖血糖与多个品牌的 CGM 数据纳入同一管理方向。[8、11]

核心能力。官方列出血糖、尿酸和饮食、运动、用药记录，以及历史数据、统计、分析和报告。硬件连接包括配套测量仪和胰岛素笔环；公开说明已支持雅培瞬感、三诺爱看、微泰等 CGM 数据对接。接入方式、同步延迟、历史回填范围和数据完整性未获得手机端验证。[8]

智能与支持。IDSS 依据血糖数据提供个性化反馈，官网同时提供食品、药品信息和教育内容。当前商店说明提及大语言模型、AI Agent 与问答能力，具体入口、覆盖用户和生成质量仍需实测。家属共享有官方服务介绍支持。[9、11]

商业模式。公开资料显示免费患者 App 与硬件、耗材及试纸计划相结合，并提供产业合作方案。可以确认其收入路径不局限于单一 App 会员；本次未取得可以稳定复核的当前会员价格或全部权益表，因而不列具体单价。[9、10]

优势与使用摩擦

优势在于数据种类和设备来源较广。对同时使用指尖监测与阶段性 CGM 的用户，这减少了长期历史分散的可能。多种图表和反馈也让用户有机会从记录进入理解。对新产品而言，“多品牌汇总”已经是需要正面比较的现有能力。

评论暴露的是数据与操作的连续性：2026 年 10 月一名 4.3.31 用户反馈向苹果健康重复写入血糖；2026 年 3 月的 4.3.24 用户觉得改版后原先集中录入的内容变得不便。这些反馈发生在特定版本，后续是否解决需实测。[U01、U02]

值得借鉴与后续核验

值得借鉴的是把记录、趋势和解释连接起来，以及为不同设备保留连续历史。后续需要核对跨品牌接入是否要求额外授权或人工操作、重复记录如何处理、用户能否看到数据来源、医生接收报告的形式。记录项目丰富时，还应观察用户完成一次真实任务需要跨多少页面。

5.2 爱看健康与小诺智能体

定位与用户。爱看健康以三诺 CGM 用户为基础，把连续监测与日常行为解释、专业服务结合。其价值主张从“看见血糖”扩展到帮助用户理解饮食、运动和用药背景下的变化；适合有持续或阶段性传感器使用条件的用户。[14、15]

核心能力。当前官方说明包含实时趋势、每日总结、TIR、AGP 及监测结束后的报告，覆盖饮食、运动与用药记录，并接入苹果健康和华为运动健康。按其说明，佩戴满 5 天可生成 AGP。该条件是产品报告入口说明；对报告是否足以支持具体临床判断仍需结合数据质量。[15]

AI 演进。2.0.0 版本于 2025 年 10 月推出小诺智能体；2026 年版本记录继续扩展健康洞察、食物拍照预测及餐后分析、多日规律解释。2.6.0 的高低血糖预测预警列为体验官计划。比较时将已公开发布的助手功能和限定试用功能分别标注。[15]

服务与收入。官方宣传专业医护团队在线服务，医生端爱看服务支持获授权患者的血糖数据查看。患者端的基础使用依托传感器，设备和耗材是明确的商业入口；具体服务包、AI 权益是否另收费及响应时限，本次没有完整价格与服务合同可供核验。[14、17]

优势与使用条件

其优势是连续数据、生活记录和解释能够在同一体系中发生，比仅凭零散输入给出通用建议有更多上下文。官方展示界面把当前值、短期趋势和团队入口放在相邻区域，有助于从异常或疑惑转向求助。

使用条件也较明确：持续价值依赖设备覆盖和有效记录。停止佩戴后，AI 是否仍能提供有用的管理支持、跨品牌数据如何接续，以及专业服务是否与购买权益绑定，都是影响长期留存的关键问题。小米商店的维护提示只反映该下载渠道，本次 iOS 和官网仍有近期更新与下载证据。[12、14、16]

评论与可借鉴设计

最近评论提到趋势、报警、饮食记录及报告的帮助，也出现 AI 与苹果健康联动的正向描述。由于样本时间集中且评分一致，报告只将这些内容作为具体使用场景线索。[U04、31]

值得借鉴的是将一次饮食行为与之后的曲线关联，以及让解释贴近当天的实际记录。新进入者如果同样定位于拍照饮食加 AI 控糖，需要证明相对现有设备生态的显著价值，获客和数据条件都会形成较高门槛。

5.3 瞬感宝及瞬感云和瞬感通生态

定位与用户。瞬感宝是雅培辅理善瞬感系统的患者软件，主要解决配套传感器数据的获取、查看和分享。其价值依赖监测设备，同时通过报告与共享工具连接患者、家属和医护人员。[18、19]

核心能力。中国区说明列出当前读数、趋势箭头、历史记录、饮食与胰岛素等备注、TIR 和日趋势报告，并支持在授权下向医生及家属共享。瞬感 2 的当前描述包含自动读数与高低报警，早代扫描方式和部分旧脚注仍同时出现在页面中；实际行为需按传感器代际、手机兼容性和启用方式核验。[18]

配套生态。LibreView 官方患者文档提供账户、报告查看及医生机构连接流程；LibreLinkUp 指南说明家属邀请与接受路径。全球文档注明地区差异，本报告以中国商店确认的共享能力为基础，用这些文档分析协作步骤，不直接认定所有报告和导出格式在中国版都已可用。[21、22]

商业模式。软件服务于配套设备与耗材使用，传感器购买构成主要消费入口。未查得报告查看需单独订阅的可靠材料；各代设备与销售渠道价格变化较大，本报告不采用一次促销价格进行成本比较。

优势与使用摩擦

优势在于当前值、方向和历史趋势的清晰表达，以及标准化统计与共享路径。医生已经能够通过现有生态获得部分监测信息，新产品需要研究剩余的沟通任务，而非把“生成血糖报告”视为独有能力。

近期评论中，2.13.1 用户提出难以沿曲线查看某一时点或峰值细节，也有用户反馈连接问题并希望接入苹果健康。它们提示高层摘要与细节追溯之间存在张力，尚需在指定机型与系统上复现。[U05—U07]

值得借鉴与后续核验

可借鉴的是以当前值、变化方向和统计周期形成逐层阅读结构，以及明确的邀请和授权关系。复诊时，患者可以先展示摘要，再按医生问题查具体日期与事件。后续应核验国内账户的实际报告入口、导出文件、停用共享以及家属接收的时间延迟。

分析报告属于数据理解层。此次未获得中国患者端通用生成式 AI 助手的明确证据；其优势主要表现为监测和报告体系。雅培 2024 年小程序公告中的未来计划按计划信息保留，不计作当前已上线能力。[20]

5.4 平安好医生

定位与用户。平安好医生是综合医疗与健康服务平台。与专门的血糖工具相比，它主要帮助用户找到医生、进行线上咨询、理解报告并衔接购药或就医服务。用户可能直接购买服务，也可能通过企业或保险相关权益进入。[23、25]

核心能力。公开移动首页可见快速问诊、名医专家、家庭医生、医典及健康服务入口。开发者说明包含家庭医生、图文咨询、体检报告解读、就医服务推荐，以及药品识别等 AI 功能。公开 HealthKit 说明列出步数、睡眠、体重、心率；本次没有找到可确认患者端连续血糖接入和专门血糖日志的当前证据。[23、24]

服务与收入。2026 年中期报告把家庭医生、AI 与真人服务结合，并披露面向个人、企业等客户的业务。商业价值由服务和权益体系承载。具体一次问诊价格、是否包含复诊、服务医生是否连续及会员使用条件依产品权益变化，需要在真实账号下核验。[25]

优势与使用摩擦

平台优势是医生与后续服务供给。当患者的主要问题是找到服务、解释体检结果或安排就医时，这类平台有更完整的承接条件。新产品如果要延伸到线上诊疗，就会面对医生资源、排班、服务质量与支付渠道的竞争。

公开首页的入口较多，用户需要先分辨问诊、家医、会员和其他服务。从居家记录进入一次复诊的路径，在本次公开层级中未完整呈现。这个观察说明平台在当前资料中更突出服务选择；实际糖尿病专项管理权益仍需账号核验。

评论里有用户因原登录方式变化担心历史记录丢失，也有付费咨询响应不及时的个案。前者关系到长期健康资料连续性，后者关系到服务兑现。均为特定时间和版本的用户报告，未核验订单或后台过程。[U08、U09]

值得借鉴与后续核验

可借鉴的是将资料解读与医生沟通、转诊和后续服务相连接。复诊辅助产品即使从整理资料切入，也需要明确材料交给谁、医生如何阅读、何时反馈，以及反馈是否回到患者的长期记录中。

平安的竞争壁垒来自医疗服务组织和客户渠道。对从零起步的团队，直接建设综合医疗平台资源要求较高。与已有门诊或医生协作验证一个具体沟通环节，更便于判断产品价值是否成立。

6 竞品功能对比矩阵

表中“官”表示官方公开材料确认，“评”表示仅有用户反馈线索，“待核”表示当前资料不足。“官”对应公开供给，手机端可用范围还受账号、版本、地区和设备条件影响。本矩阵没有将公开网页走查换算为原生功能实测。

6.1 采集与日常管理

维度	糖护士	爱看健康	瞬感宝生态	平安好医生
血糖录入	官：手动及配套设备；多源数据	官：配套 CGM 自动记录；手动指尖值待核	官：配套传感器；按代际扫描或自动	待核：专门血糖录入
历史管理	官：日志与多品牌 CGM 连贯展示	官：动态历史与监测报告	官：历史读数、日志及云端报告	待核：连续血糖历史
趋势统计	官：曲线、统计、分析报告	官：日趋势、TIR、AGP、结束报告	官：TIR、日趋势；云端报告有地区差异	待核：血糖趋势；有其他健康图表
饮食运动用药	官：记录与知识库；配套笔环	官：饮食、运动、用药；健康平台同步	官：饮食、胰岛素和运动备注	官：健康咨询、购药；结构化日常记录待核
CGM 接入	官：雅培、三诺、微泰等；机制待测	官：三诺体系；其他品牌待核	官：辅理善瞬感体系；不作通用接入	待核：未取得当前接入清单

主要依据：糖护士 [8、11]；爱看 [14、15]；瞬感 [18、22]；平安 [23]。

如何理解覆盖差异

糖护士更接近多来源健康记录容器，爱看与瞬感更依赖各自传感器形成持续数据。平安好医生则以服务为主。对用户而言，选择通常受到现有设备、医生习惯和权益来源影响，单纯比较界面中的功能数量会忽略这些条件。

“自动记录”解决数值输入，但饮食份量、临时用药变化、症状和生活事件仍需要额外背景。现有产品已提供部分事件记录入口；真正值得研究的是用户是否愿意补充、信息能否保持准确，以及医生在何时用到它。

数据聚合也有不同层次：显示一段曲线、保留完整历史、识别重复与缺失、追溯原始来源，并非同一个能力。本次官方材料确认了部分聚合供给，尚缺实际数据集去比较接入深度。

6.2 AI 与医疗协作

维度	糖护士	爱看健康	瞬感宝生态	平安好医生
AI 辅助	官：IDSS；披露大模型及 Agent，入口待测	官：小诺、饮食分析、健康洞察；预测预警为体验计划	官：趋势及报告分析；生成式助手待核	官：药品识别、医典自查；AI 与医生协同
医生咨询与随访	当前服务范围及响应权益待核	官：专业团队；医生端授权查看	官：向医生共享；共享本身不含医生咨询	官：专科问诊、家庭医生、报告解读
复诊准备	官：数据分析和报告；背景及问题整理待核	官：动态血糖总结；完整复诊准备待核	官：统计报告、医生共享；综合背景整理待核	官：报告解读和就医服务；血糖专用材料待核
报告导出	格式与范围待核	格式与范围待核	官：云端报告；国内文件导出格式待核	血糖专用报告导出待核
家属与分享	官：家属共享；授权流程待测	评：家人查看；当前完整机制待核	官：家人共享；邀请及接受机制有支持指南	官：家人医疗服务；共享血糖看板待核

主要依据 [9、11、15、17、18、21—25、31]。查看报告、共享数据和导出文件分开比较。

复诊支持仍需进一步拆解

既有产品已经提供趋势报告和医生共享，这部分市场供给较明确。复诊准备还包括发现资料缺口、说明治疗和生活变化、归纳患者问题，以及把这些信息和原始记录对应起来。当前公开材料对这些任务如何被完整支持的说明较少，故将其列为研究机会，而非直接判定所有竞品缺失。

医生咨询同样需要区分能力边界。具有数据共享入口，表示信息可以到达医生；是否有人及时阅读、如何反馈、是否包含后续服务，取决于机构连接或付费权益。复诊辅助产品需要在实际服务流程中验证这些环节。

7 核心业务流程与用户体验分析

7.1 公开入口实际走查

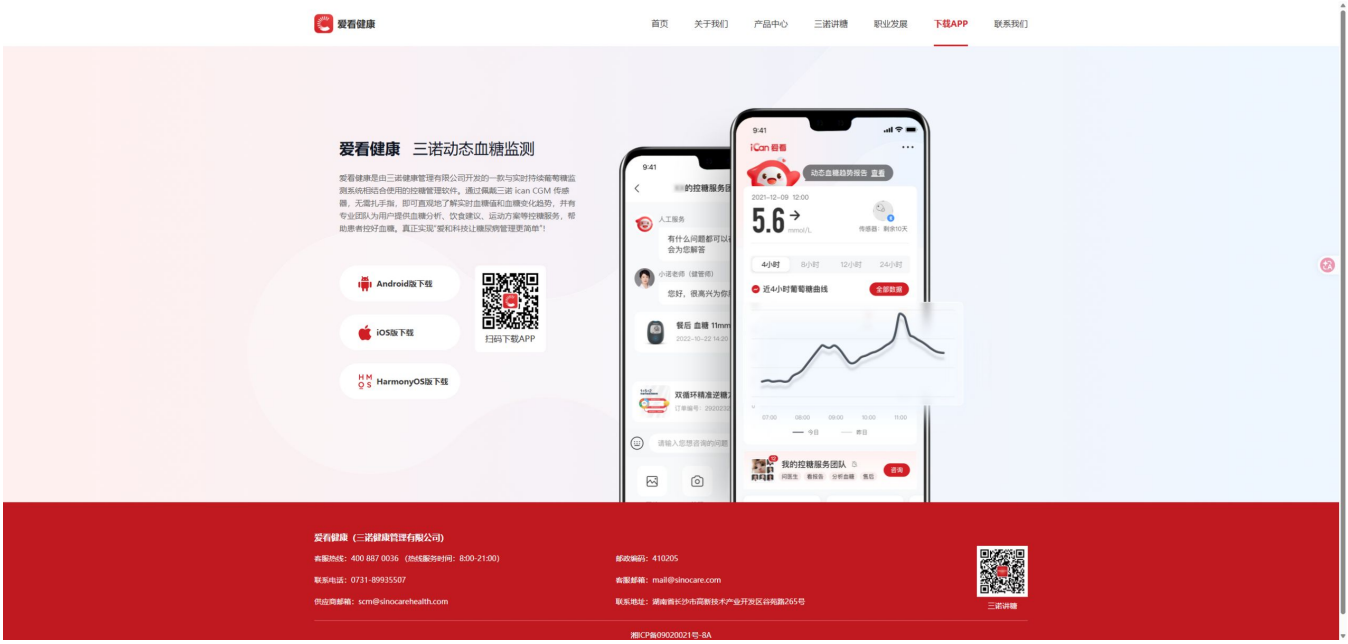


图 1 本次浏览器现场截图：爱看健康官方下载页，2026-11-02。[14] 页面中的手机图为官网展示素材。

对象	实际操作与结果	能观察到的使用成本
糖护士	打开软件页，点击“立即下载”1 次，出现应用宝新标签；落地内容被工具权限阻断。	从产品说明转至外部商店；安装后的流程尚未进入。
爱看健康	打开下载页，看到三种系统入口与产品说明；访问服务平台仅取得登录页标题。	需先选择手机系统；设备和账号前置条件随后才可验证。
平安好医生	打开移动网页，读取问诊、家医等入口及链接；快速问诊指向登录，家医指向 App。	用户先选择服务类型，再进入账号或安装环节。
雅培官网	网页标题加载，两次可访问文本均为空。	本次工具未完成页面走查，后续采用官网资料与商店说明。

官网层面，爱看对操作系统选择表达清楚，平安对服务类型分流明显。上述观察覆盖下载或服务入口，不包括注册表单验证、验证码、设备配对和新用户目标设置。原始截图与操作日志已保留。

7.2 记录与趋势的信息结构



图 2 左：糖护士数据展示；右：爱看健康监测展示。均为 2026-11-02 获取的中国区 App Store 开发者截图，示例日期较早，非本次手机实测。[11、15]

糖护士展示图将日志、表格、曲线和统计放在同一数据区域，并呈现均值、最高值、最低值等信息。这能满足从逐条检查到整体回顾的不同任务；同时，用户需要理解各视图的含义及统计周期。界面中的估算类指标还需要与检验结果保持清晰区分。

爱看展示图突出当前值、变化方向和短时间窗口，底部直接连接控糖服务团队。这种层级适合迅速了解当前状态，再查看近期趋势或寻求帮助。图中加号入口可见，但仅凭图片无法确定添加记录的字段、默认值及保存后的反馈。

两种结构反映了不同工作重心：一种便于回顾多维历史，一种围绕连续监测的当前状态。新产品若服务复诊，需要进一步观察患者能否从摘要迅速找到医生询问的那一天和相关事件。

7.3 摘要理解与服务入口



图 3　左：瞬感宝范围内时间展示；右：平安好医生家庭医生展示。来源为中国区商店官方展示图，非本次手机实测。[18、23]

瞬感宝将不同区间的时间占比组织为一屏摘要，周期切换位于下方，适合快速比较近期总体情况。用户若要解释某次峰值，还需要继续进入按日或具体时点的记录。评论对峰值和时点查询的需求，为这一层级跳转提供了实际问题线索。[U05、U06]

平安展示图把医生身份、咨询入口、排班与权益放在服务页中，降低了“下一步联系谁”的不确定性。用户同时需要理解自己持有什么权益，以及咨询是否由同一位医生持续承接。

值得借鉴的共性是为核心任务建立清楚的下一步：当前情况连接趋势，摘要连接细节，疑问连接可获得的服务。对于低数字技能用户，这些路径是否容易发现，仍需通过真实任务观察验证。

7.4 从记录到共享的流程分析

下图按现有产品公开能力归纳一次管理与复诊过程，用于定位任务之间的衔接点。它是研究者的业务分析图，不是拟建产品原型，也不代表某款 App 的逐屏流程。

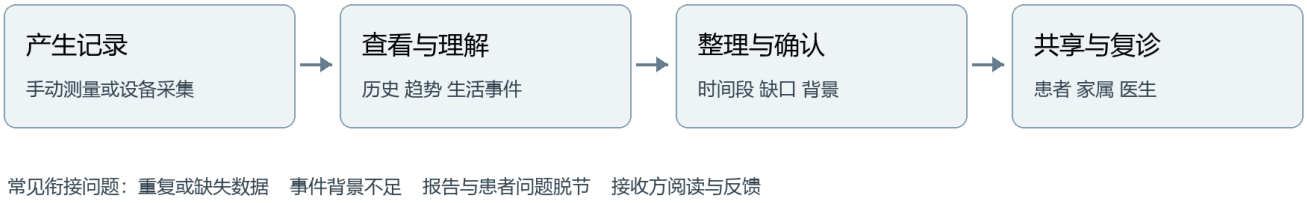


图 4 根据竞品公开能力与用户问题归纳的业务流程。

新增一条记录的完整链条还有哪些证据缺口

一条有效记录需要经过入口选择、数值与时间等信息填写、提交、保存反馈、历史回读以及必要的修改。糖护士官方确认记录能力，爱看和瞬感确认设备数据与事件记录；本次未实际完成保存及回读，因此无法可靠计算手机操作步骤。后续体验应同时验证测量时点、单位、来源、误填修正和重复记录处理。

共享流程对使用成本的启示

LibreLinkUp 支持指南中的流程涉及患者发出邀请、接收方建立或使用账号、验证并接受连接；LibreView 医生共享则涉及机构标识或邮件邀请。共享依赖双方完成设置，只有发送端完成操作还不够。这里采用官方文档归纳，国内账号的具体步骤需以当前版本核验。[21、22]

历史查询与趋势回顾的可见入口较充分，健康事件的填写质量和医疗服务的实际接续更难从截图判断。下一轮手机体验应优先选择糖护士与爱看各完成一条记录，再以瞬感验证报告到医生端的接收过程，以便覆盖手动、多设备、连续监测三种条件。

8 用户痛点与需求分析

8.1 有来源支持的用户问题

问题	证据及范围	对产品研究的含义
记录和学习负担	老年患者质性研究出现复杂操作、时间成本和信心问题；糖护士历史改版评论反映集中记录习惯受影响。[5、U02]	减少重复填写；优先观察现有习惯和首次学习过程。
数据不一致与分散	糖护士评论出现苹果健康重复写入；官方已把跨品牌碎片化作为解决对象。[U01、8]	聚合后仍需去重、来源和同步状态。
难以追查具体变化	瞬感宝近期评论询问峰值时点与曲线细节；社区研究出现解释和知识不足。[U05、U06、6]	总体指标之外，需能找到具体事件和对应时间。
监测与服务连续性	部分评论反映连接失效、账号路径变化或咨询等待。[U06、U08、U09]	持续服务包含设备、账号、资料和响应多个条件。
沟通受到信息与时间约束	广州全科医生研究涉及时间和沟通障碍；现有生态已提供报告共享。[7、22]	进一步观察就诊时缺哪些资料、谁负责整理和核对。
家庭支持影响采用	老年患者研究强调家属及专业支持；共享指南需要双端设置。[5、21]	让家属参与可能有帮助，也会增加设置与授权成本。

这些问题不是同一种“缺功能”。重复写入属于数据质量，找不到峰值属于查询能力，解释困难涉及知识与上下文，咨询等待涉及服务供给。研究下一步需要分别定位原因，避免把所有问题都归结为增加 AI 对话入口。

频繁手动输入的负担对离散监测和生活事件更突出；CGM 用户的主要负担可能转向连接、报警、佩戴和解释。用户分群应以实际监测方式和管理习惯为基础，而不只按疾病名称划分。

8.2 从已有证据到待验证需求

“复诊材料整理”得到的支持主要来自沟通障碍研究、现有报告能力及记录连续性问题。本次尚未直接观察一场糖尿病门诊，也没有测得患者整理材料或医生阅读所耗时间。因此，以下需求以可验证假设列出。

需求假设	推导依据	下一步需取得的证据
复诊前按时间整理多来源记录有价值	已有跨品牌聚合供给；同步和连续性仍有摩擦。	使用两个以上来源的患者如何准备资料，实际遗漏及重复在哪里。
用药变化与症状背景比再增加一张图更有帮助	现有趋势报告成熟；门诊沟通需要患者提供额外背景。	医生在真实复诊中反复追问哪些内容，患者能否准确补充。
患者问题清单可改善就诊准备	解释和沟通存在障碍，线上服务不能覆盖所有门诊场景。	患者是否有未问清的问题，提前整理是否增加有效交流。
家属可承担部分整理工作	老年使用研究支持家庭帮助的作用。	谁愿意参与、可见信息范围、双方操作与撤回授权成本。

8.3 用户分群与优先顺序

优先访谈已经规律监测、近期有复诊安排的 2 型糖尿病患者。他们有可整理的数据和明确的使用时机，便于判断问题是整理成本、解释困难，还是医生根本不需要更多材料。其中应同时包含指尖监测、阶段性 CGM 和多来源记录者。

第二类为主要由家属协助管理的老年患者，用来研究设置、记录和授权的实际分工。其价值可能来自减少学习和沟通负担，但家庭支持本身的可获得性差异很大。

长期 CGM 或精细胰岛素管理用户对实时性和专业解释要求更高，也更依赖成熟设备生态。可将其作为高要求参照组；从零进入这一群体，需要更多设备兼容、数据可靠性和专业服务资源。

需求优先级的依据

优先级应由具体任务出现频率、现有处理成本、问题后果和可触达性共同决定。当前资料适合提出访谈顺序，尚不适合给出全国需求占比、付费转化率或预设功能优先级。

9 市场机会及产品差异化分析

9.1 已经成熟的能力与剩余空间

本次样本中，数值采集、历史列表、曲线、统计与基础生活记录已经较常见；CGM 配套产品对实时趋势、周期报告和共享也已有清楚方案。记录数量更多、图表更多或增加通用问答，很容易与既有供给重叠。

改善空间集中在已有能力之间的衔接质量：数据在多个系统间是否一致，摘要能否追溯到原始时点，生活与治疗变化是否被准确记录，以及接收者能否快速使用整理结果。它们需要真实任务证据，单凭功能清单很难评价。

9.2 AI 可能创造价值的具体环节

环节	可能的实际价值	必须验证的质量条件
资料识别与归类	从已有记录中提取时间、来源及项目，减少重复转写。	日期、单位和来源准确；缺失项显式保留；用户可核对。
跨期对照	帮助找出监测期间、记录空白和用户确认过的变化。	区分不同数据类型和监测密度；统计过程可复核。
背景整理	把用药变化、症状与事件按时间组织，提示需要补充的事实。	不把推测写成已发生事件；保留患者原述与修改。
复诊问题组织	将患者疑问与对应资料关联，便于就诊时查看。	问题贴合真实关切，长度适合门诊，医生觉得有用。
面向不同读者的表达	患者看清楚重点，医生迅速回到数据依据。	解释能追溯；相同事实在不同版本中保持一致。

上述方向中的 OCR、整理和摘要仍可能出错。真正有差异的产品能力是让错误容易被发现和修正，并使使用成本低于原有做法。可以先用人工协助整理验证价值，再判断哪部分值得交给 AI。

9.3 数据与服务边界对定位的影响

医疗健康数据属于敏感个人信息，多方分享需要明确目的、范围和相应授权。[28] 如果定位延伸到互联网诊疗及处方，还需满足诊疗主体和相关监管要求。[29] 因此，资料整理方向的早期验证应聚焦事实组织与沟通效果；诊疗决策与服务承接由实际医疗合作流程决定。

10 候选产品定位比较

方向	用户价值	竞争程度	实现难度	主要风险
A 复诊前资料整理与沟通准备	减少重复找资料和讲述背景，帮助医生核对。	中高。既有报告、共享与通用整理工具均构成替代。	中高。需处理多源质量、时间线和医生阅读习惯。	使用频率低；医生不采纳；额外录入抵消收益；付费主体不清。
B 日常饮食与血糖解释助手	把饮食和血糖变化连接，提供即时理解与行动支持。	高。小诺、糖护士及设备生态已有相近供给。	高。依赖连续数据、食物与份量识别、个体差异处理。	建议失准；持续记录负担；获客与传感器生态依赖。
C 家属参与的低门槛管理	让有照护需要的患者获得设置、回顾和沟通帮助。	中高。共享功能已成熟，支持方式仍有改进空间。	中高。双端协作、权限、提醒和家庭分工复杂。	家属负担；患者自主性受影响；过多提醒；责任预期不一致。

以上为研究者定性比较，依据第 5—9 章的产品供给与用户问题；没有给出缺乏数据基础的数值评分。

方向 A 的价值成立条件

必须找到有材料、确实费力整理、且医生愿意阅读的一组用户。优势不能只来自生成一份长报告，而应表现为资料更准确、缺失更清楚、问题更集中、阅读更顺畅。若医生仍需从头核对，患者还要额外填写大量内容，价值就难以成立。

方向 B 的进入条件

适合已经具备监测设备、持续数据或专业服务资源的团队。新进入者需要找到现有助手没有服务好的特定人群或情境，并通过真实效果取得优势。对当前从零开始的项目，这一路径对数据和服务资源要求较高。

方向 C 的进入条件

适合有明确照护关系和家庭沟通问题的用户。它可以作为方向 A 的特定人群扩展，但若独立成为主定位，需要先证明家属愿意长期参与，并找出比现有共享看板更有价值的任务。

11 推荐的产品方向及后续建议

11.1 推荐优先验证方向 A

建议优先围绕“已有居家监测资料的 2 型糖尿病患者，在门诊复诊前整理资料和准备问题”开展下一轮研究。聚焦的价值是帮助患者准确交代近期情况，让医生在有限时间内找到需要核对的信息。

理由有三点。第一，竞品已经解决大量采集和趋势展示工作，复用现有记录有利于减少用户重新迁移和持续输入的成本。第二，数据质量、解释和沟通问题有具体资料支持，能够围绕一次复诊观察结果。第三，这个方向可先通过人工整理样本验证，不必先建设完整设备平台或综合医疗服务。

差异化应落在来源追溯、事实确认和适合门诊阅读的组织方式上。跨品牌数据接入、AI 总结和报告导出本身都已有竞争供给，产品需要证明这些能力组合后确实减少患者与医生的工作。

11.2 产品交付模式与首版范围

第一版采用患者端生成并导出 PDF 的交付模式。患者在产品中管理自己的血糖及相关健康记录，由 AI 辅助整理数据、总结变化并生成复诊摘要。患者检查并确认报告内容后，导出 PDF，携带至医院向医生展示。

第一版暂不开发以下功能：

- 医生端独立工作台。
- 医生账号及登录体系。
- 医院 HIS 系统对接。
- 医生在线查看患者数据的功能。
- 在线问诊及诊疗服务。

11.3 进入需求分析前的验证安排

验证活动	建议样本或材料	需要回答的问题
患者情境访谈	建议先访谈 12—15 人，覆盖指尖监测、阶段性 CGM、多来源和家属协助。	上次复诊带了什么、遗漏什么、如何整理、耗时在哪。
医生访谈与材料回顾	建议 5—8 名内分泌或相关基层医生；使用获得授权的去标识材料。	医生实际看什么，哪些内容多余，哪些背景最常缺失。
完整竞品任务体验	糖护士、爱看各完成记录至回读；瞬感完成报告共享；平安核对真实服务权益。	字段、保存反馈、查找步骤、接收成功和导出格式。
人工辅助整理试验	小规模使用真实复诊前材料；与原有准备方式比较。	整理及核对时间、事实错误与遗漏、医生阅读和采纳情况。

这些样本数量是下一轮研究安排建议，不是统计推断样本。先取得高质量的场景证据，再决定是否扩展调研及进入正式需求分析。

11.4 决策标准

若患者存在重复整理任务，医生认可材料结构，事实核对成本可控，并找到可持续的触达或支付渠道，可继续形成产品定位和需求分析。若医生只需要现有设备报告，或资料整理主要由医院系统完成，应缩小到尚有明确负担的患者任务，或重新选择进入方向。

12 参考资料与证据索引

全部网页及接口取得日期为 2026-11-02。点击蓝色来源标题可打开原网页；公开页面可能随后更新，研究目录保留本次取得的原件及检索结果。论文中的群体与时间范围以条目说明为准。

[1] IDF 中国国家页

2024 年成人糖尿病人数 147,981,200；第 11 版图谱口径。

[2] 中国糖尿病防治指南 2024 版

中华糖尿病杂志 2025，17(1):16–139；DOI 10.3760/cma.j.cn115791-20241203-00705。书目信息。

[3] 糖尿病患者行为和生活方式干预指南 2024 版

中国全科医学 2025，28(7):777–796；自我管理教育、行为与生活方式支持。

[4] 中国糖尿病管理 App 的功能与质量评估

BMC Public Health，2023；66 款 App，检索截至 2022-12-23。

[5] 中国老年糖尿病患者使用移动健康服务的质性研究

Cai 等，Digital Health，2026；19 名受访者；DOI 10.1177/20552076261432074。

[6] 社区 2 型糖尿病患者自我管理经验质性研究

BMJ Open，2026，16:e110237；北京 4 个社区、32 人，访谈于 2025 年开展。证据采用公开摘要。

[7] 全科医生与糖尿病患者沟通障碍研究

Yao 等，BMC Family Practice，2021，22:156；广州 12 家基层机构 15 名全科医生。

[8] 糖护士官方软件介绍

血糖与生活记录、设备接入、跨品牌 CGM、IDSS。

[9] 糖护士官方服务介绍

患者 App、家属共享、设备与试纸计划。

[10] 糖护士企业介绍

数字化管理方案及产业合作；用于分析收入来源结构。

12 参考资料续

[11] 糖护士中国区 App Store

当前功能说明、版本历史、开发者展示图。

[12] Apple 中国区 Lookup 元数据快照

2026-11-02 取得；四款正式竞品与掌控的版本信息，微糖查询未返回结果。

[13] 糖护士 360 应用商店

Android 4.3.30，页面更新日 2026-07-08。

[14] 爱看健康官方下载页

Android、iOS、HarmonyOS 入口与产品介绍；本次公开页面走查。

[15] 爱看健康 小诺智能体中国区 App Store

当前说明与历史版本记录；2.6.0 预警体验官计划、2.2.0 健康洞察等。

[16] 爱看健康小米应用商店

2.4.1，更新日 2026-09-11；检索时该渠道显示维护中。

[17] 爱看服务医生端中国区 App Store

授权后的患者血糖与异常事件查看，支持服务协同分析。

[18] 瞬感宝中国区 App Store

支持传感器代际、记录与报告、医生家属共享、版本和展示图。

[19] 雅培辅理善瞬感中国官网

中国市场产品与使用入口。

[20] 雅培中国 瞬感微信小程序上线公告

2024-03-08；当时上线能力与后续计划分别表述。

[21] LibreLinkUp 快速入门指南

中国域名提供的官方指南 DOC43870 Rev. Z；本次返回英文内容，地区与版本有差异。

[22] LibreView 患者快速入门指南

官方全球文档 DOC43869 Rev. AA；账户、报告和医生共享流程，具体地区支持另行核验。

12 参考资料续

[23] 平安好医生中国区 App Store

开发者为平安健康互联网；当前功能、版本与展示图。

[24] 平安好医生移动网页

快速问诊、名医专家、家医、医典等公开入口；本次走查。

[25] 平安健康 2026 年中期报告

港交所 2026-08-27 披露；商业模式、家庭医生与 AI 战略。原 PDF 已保存。

[26] 掌控糖尿病中国区 App Store

5.1.2，最后版本时间 2020-03-10；历史参照。

[27] 微糖中国区历史 App 地址

当前 Lookup 未返回；页面读取失败，当前患者端状态待核。

[28] 中华人民共和国个人信息保护法

医疗健康属于敏感个人信息；第二十八、二十九条。

[29] 互联网诊疗监管细则 试行

官方转载；诊疗主体与人工智能自动生成处方等管理要求。

[30] 糖护士中国区最近评论原始接口

按 mostrecent 获取第 1 页 50 条；原评论 ID、时间、版本随原件保存。

[31] 爱看健康中国区最近评论原始接口

同口径 50 条；均为 5 星，日期集中于 2026-10-29 至 10-31。

[32] 瞬感宝中国区最近评论原始接口

同口径 50 条；作为具体使用障碍线索。

[33] 平安好医生中国区最近评论原始接口

同口径 50 条；剔除与糖尿病管理无关的购物物流等内容。

12.1 选用评论索引

以下均为用户自述的转述摘要，保留原评论 ID 以便在已归档 JSON 中定位。日期采用原 RSS 的日期部分，版本为评论所关联版本。原始接口见 [30—33]。

索引与产品	日期与版本	问题或正向体验摘要
U01 糖护士 ID 14652619843	2026-10-10 v4.3.31	血糖同步至苹果健康出现重复项，需要人工删除。
U02 糖护士 ID 13906291794	2026-03-31 v4.3.24	改版后记录页面不再符合原有集中填写多项目的习惯。
U03 糖护士 ID 11705356755	2024-09-09 v4.3.17	认为图表便于向医生展示，提醒有帮助。
U04 爱看健康 ID 14728664987	2026-10-30 v2.5.1	认为趋势、报警、饮食运动记录和报告有助于管理。
U05 瞬感宝 ID 14325513229	2026-07-20 v2.13.1	希望沿时间查看曲线，认为当前查看细节不便。
U06 瞬感宝 ID 14141889766	2026-06-03 v2.13.1	希望看到峰值的具体时间和数值，同时反馈信号丢失。
U07 瞬感宝 ID 14210925097	2026-06-21 v2.13.1	希望支持苹果健康。
U08 平安好医生 ID 13420591965	2025-11-20 v9.24.0	因 QQ 登录入口变化担心无法访问历史记录。
U09 平安好医生 ID 11975130964	2024-11-21 v8.55.0	反馈付费咨询后等待回复的体验较差。

评论用于提出复现任务与访谈线索，本文未将个别用户反馈写为普遍发生率。历史版本问题是否仍存在，已在相应竞品分析中列为后续核验事项。

12.2 证据覆盖与研究复核

复核项	本次结果
样本代表性	覆盖专门管理、国产 CGM 加 AI、CGM 报告共享生态、综合医疗平台；两款历史候选说明排除原因。
当前状态	采用 2026-11-02 实时元数据，并与官网、商店或企业披露交叉核对。当前维护与核心功能实测分别表达。
功能证据	统一维度；对报告查看、共享和导出分别记录；限定试用、地区差异及待核项保持可见。
体验真实性	现场网页截图与官方展示截图分别标注；未给原生手机任务编造点击数或成功结果。
用户问题	学术研究、具体评论和分析分开；评论保留版本与 ID，采样偏差集中说明。
推荐推导	从成熟采集与报告能力、连续性问题及沟通需求推导复诊准备方向，同时列明价值验证条件。
原始资料	原始网页、接口数据、200 条评论、图片及报告保留在独立研究目录。

影响结论的主要信息缺口

当前缺少真实手机端端到端操作、测试设备数据、国内完整导出样本和直接门诊观察。因此，报告对公开功能覆盖和定位差异的判断较充分，对实际操作效率、AI 输出质量、医生采纳和付费意愿的判断仍需下一轮研究。

下一步最能改变定位结论的证据，是复诊中反复出现的资料问题、医生是否使用整理结果，以及患者是否愿意承担必要的确认工作。取得这些证据后，再进入独立的产品需求分析。